

1. Introducción y relevancia clínica

El **sueño** es un estado fisiológico activo, regulado por complejas interacciones neurobiológicas, indispensable para la **homeostasis cerebral, inmunológica y metabólica**.

Los **trastornos del sueño** constituyen una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria y salud mental. En Chile, cerca del **40% de los adultos reporta problemas de sueño**, y un **15% cumple criterios de insomnio clínico** (ENS 2020).

La **higiene del sueño** representa la **primera línea terapéutica universal** para todos los trastornos del sueño, mientras que el **tratamiento farmacológico** se reserva para casos moderados o graves, o cuando fracasan las medidas conductuales.

Relevancia clínica

- El sueño insuficiente se asocia a **mayor riesgo de depresión, diabetes, hipertensión, obesidad y deterioro cognitivo**.
- En adultos mayores, la alteración del sueño incrementa el riesgo de **caídas y deterioro funcional**.
- En el contexto del **EUNACOM**, los temas relacionados con insomnio, higiene del sueño y uso racional de hipnóticos son de **alta frecuencia** en preguntas clínicas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Regulación del sueño

El sueño es el resultado del equilibrio entre dos procesos:

Proceso	Descripción	Neurotransmisores involucrados
---------	-------------	--------------------------------

Homeostático (S)	Aumenta la presión de sueño con las horas de vigilia.	Adenosina, GABA
Circadiano (C)	Regula el ciclo sueño-vigilia en función de la luz solar.	Melatonina, serotonina

Ambos procesos interactúan para generar un patrón de sueño nocturno estable (~7–9 h en adultos jóvenes, 6–7 h en adultos mayores).

2.2. Fases del sueño

1. Sueño No REM:

- N1: transición vigilia-sueño.
- N2: fase intermedia (50% del tiempo total).
- N3: sueño profundo o de ondas lentas (restaurador).

2. Sueño REM:

- Asociado a sueños, consolidación de la memoria y regulación emocional.
- Predomina en la segunda mitad de la noche.

Con la edad:

- Disminuye el sueño profundo (N3).
 - Aumentan los despertares y fragmentación.
 - Se acorta la latencia REM.
-

2.3. Factores que afectan el sueño

- **Psicológicos:** ansiedad, depresión, estrés.
- **Fisiológicos:** dolor, reflujo, apnea, nocturia.

- **Ambientales:** ruido, luz, temperatura.
- **Farmacológicos:** ISRS, corticoides, betabloqueadores, cafeína.
- **Comportamentales:** uso nocturno de pantallas, irregularidad horaria, siestas prolongadas.

□ La mayoría de los casos de insomnio crónico se deben a **malos hábitos de sueño perpetuados en el tiempo**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Los síntomas de alteración del sueño pueden clasificarse en tres ejes:

1. **Insomnio:** dificultad para iniciar o mantener el sueño, o despertar precoz.
2. **Hipersomnia:** somnolencia excesiva diurna.
3. **Parasomnias:** conductas anormales durante el sueño (sonambulismo, pesadillas, terrores nocturnos).

3.1. Manifestaciones generales

- Fatiga diurna, irritabilidad, dificultad de concentración.
- Cefalea matinal, sensación de sueño “no reparador”.
- Cambios en el rendimiento laboral o académico.
- Alteraciones del apetito y estado de ánimo.

3.2. Diagnóstico diferencial

Condición	Características diferenciales
Trastorno depresivo	Despertar precoz y anhedonia.

Trastorno de ansiedad	Dificultad para conciliar el sueño, rumiación mental.
------------------------------	---

Apnea del sueño	Ronquidos, pausas respiratorias, somnolencia matinal.
------------------------	---

Uso de estimulantes	Cafeína, nicotina, fármacos activadores.
----------------------------	--

Dolor crónico	Fragmentación del sueño.
----------------------	--------------------------

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico de los trastornos del sueño es **fundamentalmente clínico**, basado en:

- Historia del sueño (inicio, duración, despertares, hábitos previos).
 - Repercusión diurna (fatiga, ánimo, atención).
 - Uso de diario o registro de sueño por 1–2 semanas.
-

4.2. Instrumentos complementarios

- **Escala de somnolencia de Epworth:** somnolencia diurna (>10 = anormal).
- **Índice de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI).**
- **Cuestionario STOP-BANG:** cribado de apnea del sueño.
- **Actigrafía:** mide movimientos para estimar patrones de sueño.
- **Polisomnografía:** estándar de oro para sospecha de apnea, narcolepsia o parasomnias complejas.

4.3. Criterios DSM-5 para insomnio

1. Dificultad para iniciar o mantener el sueño, o despertar precoz.
2. Al menos 3 noches/semana durante 3 meses.
3. Repercusión funcional diurna.
4. No atribuible a otra condición médica, psiquiátrica o farmacológica.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento del sueño se basa en un **modelo escalonado**:

1. **Higiene del sueño (base).**
2. **Terapia cognitivo-conductual (TCC-I).**
3. **Farmacoterapia (uso temporal).**

5.1. Higiene del sueño (pilar fundamental)

Área	Recomendaciones clave
Horario	Mantener hora fija de acostarse y levantarse, incluso fines de semana.
Ambiente	Dormitorio oscuro, silencioso, ventilado y con temperatura agradable.
Actividades previas	Evitar pantallas, luces intensas, comidas copiosas o ejercicio intenso 3 h antes de dormir.

Sustancias	Evitar cafeína, alcohol, nicotina y estimulantes desde 6 h antes.
Rutina pre-sueño	Actividades relajantes: lectura ligera, respiración profunda o música suave.
Cama	Solo para dormir o actividad sexual (no para leer o ver TV).
Siestas	Evitar o limitar a 20–30 min antes de las 17:00 h.
Ejercicio físico	Regular, al menos 30 min/día, preferentemente matutino.
Exposición solar	Luz natural matinal para reforzar el ritmo circadiano.

☐ “La cama es para dormir; si no duermes, levántate.”
(Principio conductual básico de la TCC-I)

5.2. Terapia cognitivo-conductual para insomnio (TCC-I)

Es la **primera línea terapéutica en insomnio crónico**, con eficacia superior a los fármacos.

Incluye cinco componentes principales:

1. **Psicoeducación sobre el sueño.**
2. **Restricción del tiempo en cama:** igualarlo al tiempo real de sueño.
3. **Control de estímulos:** asociar la cama solo al dormir.
4. **Terapia cognitiva:** cambiar creencias erróneas sobre el sueño (“necesito dormir 8 h exactas”).
5. **Relajación y respiración.**

☐ Estudios (AASM, 2021) muestran que la TCC-I logra **mejoras sostenidas hasta 2 años** tras el tratamiento.

5.3. Tratamiento farmacológico básico

El uso de fármacos es **temporal** y siempre **complementario** a las medidas conductuales.

Debe limitarse a 2–4 semanas, salvo en casos seleccionados bajo supervisión médica.

A. Hipnóticos de acción corta

Fármaco	Dosis	Comentarios
Zolpide m	5–10 mg nocturno	Inicio rápido, baja tolerancia cruzada; riesgo de dependencia si uso prolongado.
Zopiclon a	3,75–7,5 mg nocturno	Efecto similar a benzodiazepinas; menos somnolencia residual.

- ☐ Evitar uso en ancianos (riesgo de caídas, confusión nocturna).

B. Antidepresivos sedantes

Fármaco	Dosis	Indicación
Trazodona	25–100 mg nocturno	Insomnio con síntomas depresivos o ansiedad.
Mirtazapina	7,5–15 mg nocturno	Útil en insomnio con pérdida de apetito o peso.
Amitriptilina	10–25 mg nocturno	Evitar en ancianos (efectos anticolinérgicos).

C. Melatonina y agonistas melatoninérgicos

- **Melatonina:** 1–3 mg nocturno (1–2 h antes de dormir).
 - Eficaz en adultos mayores y trastornos del ritmo circadiano.

- Mejora latencia y calidad del sueño sin dependencia.
- **Agomelatina:** antidepresivo con acción melatoninérgica y serotoninérgica dual.

D. Benzodiacepinas (uso limitado)

Fármaco	Vida media	Observaciones
Lorazepam (1–2 mg)	Intermedia	Uso puntual, riesgo de tolerancia.
Clonazepam (0,25–0,5 mg)	Prolongada	No recomendado en insomnio primario; útil en parasomnias REM.

□ Riesgos: dependencia, tolerancia, deterioro cognitivo, caídas, apnea.
El **MINSAL** desaconseja su uso crónico (>4 semanas).

5.4. Indicaciones específicas

Situación clínica	Tratamiento preferido
Insomnio primario leve	Higiene + TCC-I.
Insomnio moderado-grave	TCC-I + hipnótico breve.
Insomnio con depresión	Mirtazapina o trazodona.
Adulto mayor	Melatonina o dosis bajas de TCC-I + medidas conductuales.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- **Dependencia y tolerancia a hipnóticos.**
- **Caídas y fracturas en adultos mayores.**
- **Empeoramiento de depresión o deterioro cognitivo.**
- **Rebote de insomnio** al suspender benzodiazepinas.
- **Alteraciones metabólicas** (si se cronifica la privación de sueño).

6.2. Pronóstico

- Con higiene adecuada y TCC-I, el 70–80% logra mejoría sostenida.
- El pronóstico empeora con:
 - Uso prolongado de hipnóticos.
 - Comorbilidad psiquiátrica o médica no tratada.
 - Falta de adherencia a medidas conductuales.

☐ El sueño puede recuperarse gradualmente, pero requiere **consistencia conductual**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas clínicas

1. La **Terapia Cognitivo-Conductual** es más eficaz que cualquier fármaco para el insomnio crónico.
 2. La **melatonina** es el único suplemento recomendado por guías internacionales para adultos mayores.
 3. Los **hipnóticos tipo Z** (zolpidem, zopiclona) deben usarse por menos de 4 semanas.
 4. En **insomnio con depresión o pérdida de peso**, preferir **mirtazapina o trazodona**.
 5. Evitar **benzodiacepinas prolongadas**: aumentan caídas y deterioro cognitivo.
 6. La **higiene del sueño** debe enseñarse activamente en APS: es terapéutica por sí misma.
 7. El **sueño reparador** mejora la inmunidad, el metabolismo y la regulación emocional.
-



Errores comunes

- Indicar hipnóticos sin medidas conductuales previas.
 - Mantener benzodiacepinas por meses o años.
 - No pesquisar depresión o ansiedad como causa de insomnio.
 - Usar cafeína o alcohol para “regular” el sueño.
 - Ignorar apnea del sueño antes de prescribir sedantes.
 - Confundir higiene del sueño con “buenos hábitos” sin estructura conductual.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **higiene del sueño** es la base del tratamiento en todos los trastornos del sueño.
2. La **Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I)** es el tratamiento más efectivo y seguro.

3. Los **hipnóticos tipo Z** deben usarse solo de manera **transitoria (<4 semanas)**.
4. En **insomnio con depresión o pérdida de peso**, preferir **mirtazapina o trazodona**.
5. La **melatonina** es especialmente útil en **adultos mayores y trastornos del ritmo circadiano**.
6. Evitar benzodiacepinas prolongadas: aumentan **caídas, dependencia y deterioro cognitivo**.
7. El sueño adecuado previene **trastornos afectivos, metabólicos y cognitivos**.